PEP UP 通信 #207

愛着障害とはなにか③ 愛着障害の３つのタイプ

工藤 功成

米澤好史氏は、愛着障害を３つのタイプに分類しています。

① 脱抑制タイプ （脱抑制型対人交流症／脱抑制型対人交流障害）

このタイプは、誰彼なしにまったく警戒することなく人との関わりを、そして身体接触を強く求めるのが特徴です。
たとえば、幼児期・学童期では抱っこ、おんぶ、膝乗りなどを求めます。
年齢にかかわらず、中学生以上になっても、まとわりつくようなしつこい身体接触を求めたり、他者の体の一部を触ったり、距離が近かったりします。
近づく際にも、飛びつく、足下から滑り込む、攻撃しながら抱きつくなど、ある種の激しさをともなう場合があります。

脱抑制タイプの子どもは、これらの特徴により「人懐こい」と誤解されやすいのですが、安心基地が機能していないから接触を求めるのであって、愛着に問題を抱えた状態であるといえます。

すなわち、自分の気持ちをポジティブにしてくれる存在を身の回りに意識できていないので、出会う人、出会う人に〈この人なら気分を上げてくれるかも〉と期待して関わりを求めているわけです。

身体接触は、触れあうことによって感じられる「接触快」を得たくてする行動です。
積極的に身体接触を求めるというこの特徴があることで、脱抑制タイプの子どもは、とくに思春期以降、性的な問題に巻き込まれやすくなります。
かつての「援助交際」や、近年メディアでしばしば話題となる「パパ活」は、脱抑制タイプの愛着障害に起因しているケースが多いとみて間違いありません。

② 抑制タイプ （反応性アタッチメント症／反応性愛着障害）

脱抑制タイプとは正反対のような特徴を示すのが、「抑制タイプ」の愛着障害です。
人を恐れる、避けようとする、そばに寄られるのを恐れる、といった行動が特徴です。
大人からの虐待、マルトリートメント、ネグレクト（育児放棄）など、過酷な経験をした子どもは、このタイプの愛着障害になりやすい傾向があります。

脱抑制タイプは安心基地の欠如によるものでしたが、この抑制タイプ安全基地が築かれていないことからきています。

抑制タイプの子どもの中には、〈この世の中では誰も守ってくれない〉という思いが潜在しています。つまり人との関わりは「危険なもの」であり、だから避けようとしているわけです。

他者への関わりが抑制されていることから抑制タイプ（反応性アタッチメント障害）と呼ばれ、脱抑制型と区別されます。
このタイプの愛着障害の子どもは**少数**で、重度のネグレクトを受けた子どもの中でさえ、その有病率は10%未満とされています。
多くの現場に携わってきた米澤氏も、抑制型の子どもに出会うことはほとんどないと述べています。

③ ＡＳＤと愛着障害を併せ持つタイプ （ＡＳＤ＋愛着障害タイプ）

愛着障害は関係性の障害であり、相性によっては愛情を注いでも愛着の問題が起こり得ます。
これが顕著に見られるのが発達障害、その中でもASD（自閉スペクトラム症）にあわない支援をしたことによって生じる「ASDと愛着障害の併存」という状態で、米澤氏はこれを「第３のタイプ」と位置づけています。

ASD、ADHD、SLDなどは「発達障害」とまとめられることが多いのですが、**ASD＋愛着障害の組み合わせは支援に独特な難しさがあり、この第３のタイプの愛着障害が、近年とみに増えています。**

第３のタイプには、安全基地・安心基地の欠如という問題とともに、ASDの特性からくる問題が加わります。
行動面や心理面の特徴は様々ありますが、そのひとつが「籠もる」という行動です。
例えば「カーテンにくるまる」「タオルや衣類を頭からかぶる」などが籠もる行動にあたります。
そうしないと、ここが安全・安心であるという感覚（居場所感）を確保できないのです。

そして居場所感を脅かされると、激しい攻撃を示したり、逆に周囲の関りを一切拒否してシャットアウトした状態になったりします。
そうまでして居場所を確保しようとしているという、その気持ちを理解することが、関わり方を考える上でとても重要になってきます。

現在の精神医学における診断基準では、ASD（自閉スペクトラム症）と愛着障害の併存は認められていません。しかし、米澤氏が「ASD＋愛着障害タイプ」を提唱し続けているのには理由があります。

① 併存を前提として子どもを支援すると、劇的な効果が現れるから。

ASDを含む発達障害の支援については、すでに多くの情報があります。
ところが、その通りに支援してもなかなか改善しない、という声もよく聞かれます。
そうしたケースで、愛着障害へのアプローチを併せて取り入れた結果、状況が大きく好転した事例がいくつも確認されています。

② 「併存している」と考えることで、多くの症状をより合理的に説明できるようになるから。

攻撃的な反応や、固まって周囲をシャットアウトする現象はASD＋愛着障害タイプの特徴だと捉えられます。
これらの現象は従来、ASDに起因する「易刺激性・易怒性」や「カストニア（緊張病）」であると説明されてきました。
ところが、ASDによるとされるそれらの症状に愛着障害の併存を想定しなければ、この現象は説明ができません。
また、易怒性やカタトニアは、いずれも統合失調症など、他の精神障害でも現れる症状ですが、ASDと愛着障害の併存の可能性があらかじめ除外されていると、治療や支援が初手から躓きかねません。

その想定がないと、たとえば「これは統合失調症の兆候である」という的外れな診断がつき、それに基づいて支援・治療が行われ、でも効果はなく、それ以上の打開策もないので、事態がますます混迷を深めるという悪循環に陥るおそれがあります。
事実、そうなっているとしか思えない事例がたくさんあります。

愛着障害は「スペクトラム」です。
「愛着障害か否か」ではなく、連続体です。

愛着障害とまでは言えない人、愛着の問題を少しだけ抱えている人、大きな愛着の問題がある人、深刻な愛着障害……といった具合に、色彩のグラデーションのような多くの段階があります。
まったく愛着の問題をもっていない人などいないとも言えます。
ですので愛着障害は、本来なら「愛着障害不全」と呼んだ方が正確だと言えます。

併存の可能性も視野に入れると、愛着障害の症状である「行動の問題」（不適切行動・望ましくない行動）とその「強さ」は、次の式によって測れると考えられます。

行動の問題の強さ
＝ 自閉（ASD）の程度×愛着の問題の程度

すなわち、自閉スペクトラム症が強ければ、愛着の問題がわずかであっても不適切行動が多くなり、症例は深刻化します。
一方、自閉の程度がわずかでも、愛着の問題が多いと同じくらい、深刻な症状となり得ると捉えることができるのです。